당뇨약, 얼마나 센가요?

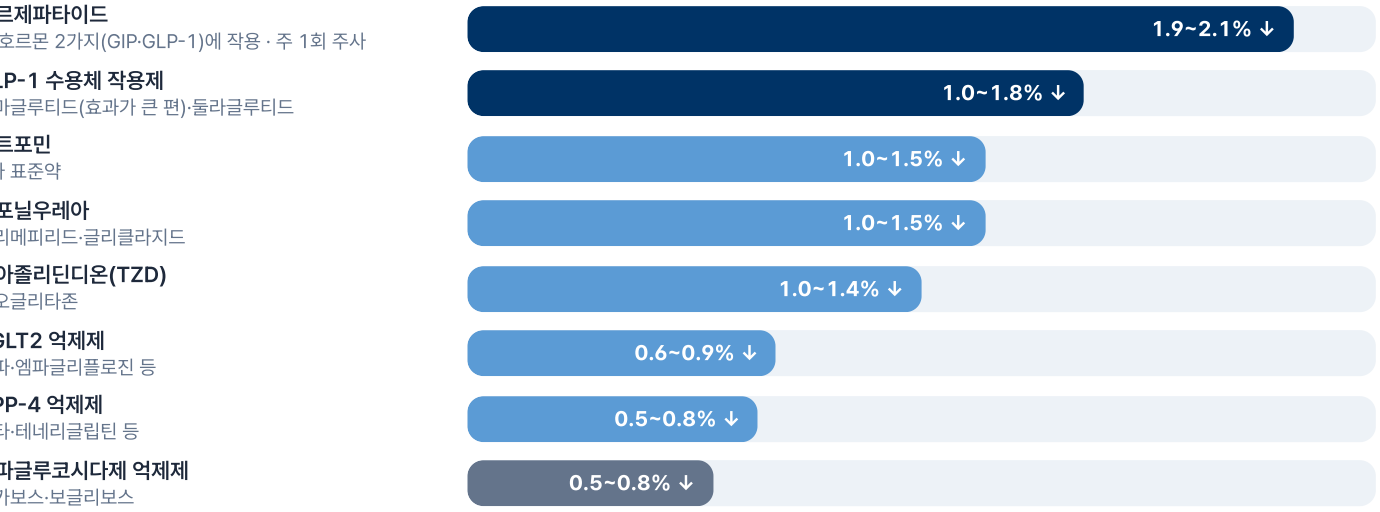
계열·성분별 비교 — 계열마다 당화혈색소(A1C)를 낮추는 힘이 다릅니다. 단, **'센 약'만이 정답은 아닙니다** — 심장·콩팥 보호, 체중, 저혈당 위험을 함께 봅니다. (2페이지: DPP-4 억제제·SGLT2 억제제 성분별 비교)

약 이름 풀이 — GLP-1 작용제: 장에서 나오는 혈당 조절 호르몬(GLP-1)처럼 작용하는 약 · SGLT2 억제제: 콩팥에서 당을 소변으로 내보내는 약 · DPP-4 억제제: 혈당 조절 호르몬이 빨리 분해되지 않게 하는 약

한눈에 보기

가장 강력 (혈당↓)	표준 1차약	심장·콩팥 보호	기저 A1C 높을수록
GLP-1 · 티르제	**메트포민**	**SGLT2 · GLP-1**	**더 많이 ↓**
A1C 최대 ~2% ↓ + 체중감소	안전·저렴·체중 중립	혈당강하 넘어선 이점	9%대는 표보다 크게 감소

계열별 당화혈색소(A1C) 강하 (%, 단독요법·강한 순)



막대 길이 = A1C 강하폭에 비례(단독요법 기준) · 근거: ADA 2026 · KDA · Tsapas 2020. 기저 A1C가 높을수록 더 크게 감소합니다.

계열별 강점과 주의점

계열	강점 · 특징	저혈당 / 체중
메트포민	1차 표준약. 저렴·안전. 속쓰림·설사 가능 → 서서히 증량.	저혈당 거의 없음 · 체중 중립
설포닐우레아	효과 강하고 저렴, 빠르게 작용. 식사 거르면 위험.	저혈당 ↑ · 체중 증가
치아졸리딘디온 피오글리타존	인슐린 저항성↓, **지방간에 도움.** 효과가 서서히 나타남.	저혈당 없음 · 체중↑·부종
알파글루코시다제 아카보스·보글리보스	장에서 당 흡수를 늦춰 **식후 혈당** 위주로 낮춤. 매 식사 직전 복용.	저혈당 없음(단독) · 가스·복부팽만
DPP-4 억제제	순하고 부작용이 적어 쓰기 편함. 혈당강하는 완만(성분별 2페이지).	저혈당 거의 없음 · 체중 중립
SGLT2 억제제	**심부전 입원·콩팥병 진행↓.** 체중·혈압↓. 요로/생식기 감염·탈수 주의 (성분별 2페이지).	저혈당 거의 없음 · 체중 감소
GLP-1 작용제 세마글루티드 등	강력한 혈당강하 + **체중감소 + 심혈관 보호.** 주사(경구 세마도 있음), 초기 메스꺼움.	저혈당 거의 없음 · 체중 감소 ↓↓
티르제파타이드 GIP·GLP-1 이중 작용	현재 **가장 강력한 혈당강하 + 큰 체중감소.** 주 1회 주사, 비교적 신약.	저혈당 거의 없음 · 체중 감소 ↓↓↓

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — ADA Standards of Care 2026(효능 분류) · 대한당뇨병학회(KDA) 진료지침 · Tsapas Ann Intern Med 2020(당뇨약 네트워크 메타분석)

본 자료는 일반적 설명이며, 실제 약 선택과 용량 조정은 주치의 판단이 우선합니다. 2페이지에 DPP-4·SGLT2 억제제 성분별 비교가 이어집니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/diabetes-drug-strength/

DPP-4 억제제 — 성분별 A1C 강하 (%, 강한 순)

성분 (상표)	A1C 강하	특징
테네리글립틴 테넬리아	~0.8%	**여러 연구를 모아 비교한 분석(네트워크 메타분석)에서 A1C 강하 1위.** 하루 한 번.
빌다글립틴 가브스	~0.75%	공복혈당 강하가 우수. **1일 2회** 복용.
제미글립틴 제미글로 · 국산	~0.7%	국내 개발. 효과·안전성 대등, 널리 사용.
에보글립틴 슈가논 · 국산	~0.7%	국내 개발. 하루 한 번, 대등한 효과.
시타글립틴 자누비아	~0.7%	가장 널리 쓰이고 **데이터가 풍부**. 하루 한 번.
아나글립틴 가드렛	~0.7%	나쁜 콜레스테롤(LDL)을 약간 낮추는 경향.
리나글립틴 트라젠타	~0.65%	**콩팥·간 기능 저하에도 용량조절 불필요** — 신장 환자에 편리.
알로글립틴·삭사글립틴 네시나 · 온글라이자	~0.6%	하루 한 번. **삭사글립틴은 심부전 이력 시 주의**(대규모 임상시험).

근거: DPP-4 억제제 네트워크 메타분석(58개 무작위 임상시험). 테네리·빌다글립틴이 상위나 **성분 간 차이는 크지 않습니다**. 신장 기능·복용 편의·복합제 구성으로도 선택합니다.

SGLT2 억제제 — 성분별 A1C 강하 (%, 강한 순)

성분 (상표)	A1C 강하	특징
엔아보글리플로진 엔블로 · 국산	~0.8%	국내 개발 **저용량(0.3mg)** SGLT2 억제제. 대등한 효과.
엠파글리플로진 자디앙	~0.7%	**심부전·심혈관 사망↓** 근거(대규모 임상시험). 적응증이 넓음.
이프라글리플로진 슈글렛	~0.7%	지방간 개선 데이터. 하루 한 번.
어투글리플로진 스테글라트로	~0.7%	심혈관 안전성 확인(대규모 임상시험). 하루 한 번.
다파글리플로진 포시가	~0.65%	**심부전·만성콩팥병 진행↓** 근거(대규모 임상시험).

성분 간 A1C 차이는 작습니다 — **핵심은 심장·콩팥 보호**입니다. 성분 중 강하폭이 큰 편인 카나글리플로진(인보카나) 300mg은 현재 국내 미시판. 공통 주의: **요로/생식기 감염·탈수·정상혈당 케톤산증**.

'센 약'보다 '맞는 약'



먹는 약과 주사약, 동반질환에 맞춰 고릅니다

혈당을 가장 많이 낮추는 약이 항상 최선은 아닙니다.

심장·콩팥이 약한 분은 SGLT2·GLP-1, **체중 감량이 필요한 분**은 GLP-1·티르제파타이드가 유리합니다.

시작은 대개 **메트포민**이며, 동반질환에 맞춰 더합니다.

함께 보기 — 설명 슬라이드 「당뇨, 오늘부터 함께 관리합니다」 edu.gwanggyobarun.com/decks/endocrine/diabetes-first-visit/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☏ 031-893-4560

근거 — Wang DOM 2025(DPP-4 억제제 네트워크 메타분석, 58개 RCT) · SGLT2 억제제 용량반응 메타분석 · 대규모 임상시험: SAVOR(삭사글립틴) · EMPA-REG(엠파글리플로진) · VERTIS-CV(어투글리플로진) · DAPA-HF/DAPA-CKD(다파글리플로진) · ADA 2026 · KDA

성분별 A1C는 단독요법 평균이며 기저 혈당·용량·병용에 따라 달라집니다. 실제 약 선택은 주치의 판단이 우선합니다.